

Пропалс тазовых органов

Информация для пациента · Когда тазовые органы опускаются, вызывая выпячивание или давление

WARWIKI

Пропалс тазовых органов возникает, когда связки и мышцы, поддерживающие тазовые органы — мочевой пузырь, матку или прямую кишку — ослабевают, и один или несколько органов смещаются во влагалище или за его пределы. Это вызывает **выпячивание или ощущение давления**. Состояние очень распространено, оно **не опасно и не является онкологическим**, и для него существуют эффективные варианты лечения — от упражнений и поддерживающего устройства до операции.

Об этом состоянии

Пропалс называют по стенке, которая опустилась:

- **Передняя стенка** (мочевой пузырь) — цистоцеле
- **Задняя стенка** (прямая кишка) — ректоцеле
- **Верхушка** (матка или свод влагалища после гистерэктомии)

Частые симптомы:

- **Выпячивание или образование**, которое вы видите или чувствуете у входа во влагалище
- **Давление или тяжесть** в области таза, нередко усиливающиеся к вечеру или при подъёме тяжестей
- Затруднение при полном опорожнении мочевого пузыря или кишечника; иногда — надавливание на выпячивание для облегчения ("сплентирование")

Причины

Всё, что создаёт нагрузку или ослабляет опору тазового дна: **беременность и роды**, менопауза и возраст, хроническое натуживание (запоры или кашель), подъём тяжестей, перенесённые операции на органах таза, избыточный вес и наследственная предрасположенность.

ТЕРМИНЫ

Пропалс

Смещение тазового органа из нормального положения.

Цистоцеле

Выпячивание мочевого пузыря через переднюю стенку влагалища.

Ректоцеле

Выпячивание прямой кишки через заднюю стенку влагалища.

Свод влагалища

Верхняя часть влагалища, которая может опуститься после гистерэктомии.

Пессарий

Съёмное устройство, вводимое во влагалище для поддержки органов.

Сплентирование

Надавливание на выпячивание для облегчения мочеиспускания или дефекации.

Тазовое дно

Мышцы, поддерживающие тазовые органы.

POP-Q

Система оценки, измеряющая степень пропалса при осмотре.

НУЖНО ЛИ ЭТО ЛЕЧИТЬ? Только если это вас беспокоит. Пролапс не опасен, поэтому при лёгких симптомах достаточно наблюдения. Если состояние влияет на комфорт или повседневную жизнь, вы можете выбрать один из нескольких эффективных вариантов — единственно верного решения нет, и со временем его можно изменить.

Как это диагностируют

- **Гинекологический осмотр**, нередко стоя или при натуживании, чтобы определить, какие стенки опустились и насколько
- Оценка симптомов со стороны мочевого пузыря и кишечника
- При необходимости — **уродинамическое исследование**, если также имеется недержание мочи

Как это лечат (шаг за шагом)

- 1 **Наблюдение** при отсутствии жалоб, а также профилактика: лечение запоров, ограничение подъёма тяжестей, контроль веса.
- 2 **Упражнения для тазового дна (Кегеля) / физиотерапия** при лёгком пролапсе.
- 3 **Пессарий** — съёмная опора, устраняющая выпячивание без операции.
- 4 **Операция** — реконструкция опоры, кольпоклеизис или подвешивание. Для каждого вида существует отдельный листок.

Жизнь с этим состоянием

- Следите за регулярным стулом и **избегайте натуживания**; не поднимайте тяжести сверх рекомендованного врачом.
- Выполняйте упражнения Кегеля; контролируйте кашель и вес.
- Пессарий может быть долгосрочным решением, а не временной мерой.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Невозможность **помочиться** или совершить дефекацию
- Выпячивание стало **болезненным, кровоточит или покрылось язвочками**
- Повышение температуры или невозможность вправить выпячивание

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Пролапс — распространённое, неопасное опущение тазовых органов, вызывающее выпячивание или давление.
2. Лечите его только при наличии жалоб — варианты включают наблюдение, упражнения, пессарий или операцию.
3. Избегайте натуживания и подъёма тяжестей. Обратитесь за помощью, если не можете опорожнить мочевой пузырь или кишечник, либо выпячивание стало болезненным или изъязвлённым.